

Białko *zamiast* cukru

Mózg ADHD nie wybacza chaosu glukozy. Białko stabilizuje, cukier daje skok i upadek, regularność daje uwagę.

CZAS: 8 min czytania Wdrożenie stopniowe

ŹRÓDŁO: Nigg i wsp. (2012, meta-analiza); Sonuga-Barke i wsp. (2013); Nazar i wsp. (2016)

JAK UŻYWAĆ

Trzy rzeczy: **śniadanie z białkiem** (nie same węglowodany), **regularne posiłki** co 3-4 godziny (alarm w kalendarzu — bo zapomnisz), **limit cukru i barwników**. Jeśli sięgasz po przekąski impulsywnie albo pomijasz posiłki — porozmawiaj z lekarzem o ryzyku zaburzeń odżywiania (12-18% dorosłych z ADHD).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Odżywianie w ADHD to **dwukierunkowa pętla**: (1) ADHD zaburza *sposób jedzenia* — impulsywne sięganie, pomijanie posiłków, kompulsywne objadanie się; (2) dieta wpływa na *objawy ADHD*. Nigg i wsp. (2012, meta-analiza): eliminacja sztucznych barwników redukuje objawy $d = 0,29$. Sonuga-Barke i wsp. (2013): omega-3 dają $d = 0,16$ — efekt mały, ale realny. Najważniejszy mechanizm: **stabilna glukoza**. Białko na śniadanie dostarcza **tyrozyny** — prekursora dopaminy, której mózg ADHD ma za mało. Spadek cukru po skoku → nasilenie nieuwagi. Nazar i wsp. (2016): **12-18%** dorosłych z ADHD spełnia kryteria zaburzenia z napadami objadania (BED).

01 Dlaczego ADHD wpływa na jedzenie

1 · ZAPOMINANIE O POSIŁKACH

W hiperfokusie — 6 godzin bez jedzenia. Mózg ADHD *nie odczuwa głodu* jako sygnału do przzerwiania. Skutek: spadek glukozy → nasilenie objawów.

2 · KOMPULSYWNE PRZEKĄSKI

Wieczorem nagle „dopadnie głód” — kompulsywne sięganie po cukier (szybka dopamina). Pętla: pomijanie → kompulsja → wstyd → znowu pomijanie.

3 · STYMULANTY OBNIŻAJĄ APETYT

Klasyczny efekt uboczny leku ADHD: brak apetytu w ciągu dnia. Trzeba **jeść zegarem**, nie głodem. Pełen posiłek zanim lek zacznie działać.

4 · RYZYKO ZABURZEŃ

12-18% dorosłych z ADHD spełnia kryteria **BED** (napady objadania). Mechanizm: impulsywność + deficyt regulacji emocji → jedzenie jako regulator.

02 Sześć zasad — co działa

1 · BIAŁKO NA ŚNIADANIE

Jajka, jogurt naturalny, twaróg, orzechy. **Tyrozyna** → dopamina. Sam płatek z mlekiem = skok + upadek do 11:00.

2 · STAŁE GODZINY

3 posiłki + 2 przekąski. **Alarmy w telefonie** — 8:00, 11:00, 13:30, 16:30, 19:00. Nie głód, tylko zegar.

3 · OMEGA-3

1000-1500 mg EPA+DHA dziennie albo ryby tłuste 2-3× w tygodniu. Efekt po **8-12 tygodniach**. Mały, ale realny.

4 · MNIEJ CUKRU

Skok glukozy 30 min, spadek 90 min — nasila nieuwagę. **Owoce zamiast słodczy**. Ograniczenie napojów słodzonych.

5 · WODA ZAWSZE OBOK

Odwodnienie 2% obniża uwagę o 10%. Butelka **na biurku, w samochodzie, przy łóżku**. Nie czekaj na pragnienie — pij zegarem.

6 · BEZ SZTUCZNYCH BARWNIKÓW

Czerwony 40, żółty 5, niebieski 1. Nigg (2012): $d = 0,29$ redukcji objawów po eliminacji. Czytaj etykiety przetworzonych produktów.

03 Twój tygodniowy plan — przykładowy

Nie wyobrażaj sobie „idealnej diety” — wybierz **realne** opcje na każdy posiłek. Zapisz dokładne godziny. Wpisz alarmy w kalendarz.

ŚNIADANIE Z BIAŁKIEM

— 3 opcje, między którymi zmieniam

LUNCH

— łatwy do zorganizowania

KOLACJA

— najpóźniej 3 godz. przed snem

PRZEKĄSKI BIAŁKOWE

— zawsze dostępne, by zapobiec sięganiu po cukier

04 Sygnały do konsultacji ze specjalistą/-tką

NAPADY OBJADANIA

Powtarzające się epizody jedzenia dużych ilości w krótkim czasie, z poczuciem utraty kontroli i wstydem.
Możliwe BED — wymaga oceny.

ZACHOWANIA KOMPENSACYJNE

Wymioty, środki przeczyszczające, kompulsywne ćwiczenia. **Sygnal alarmowy** — możliwa bulimia. Konsultacja ze specjalistą/-tką jak najszybciej.

PRZEWLEKŁY BRAK APETYTU

Jeśli przyjmujesz lek na ADHD i nie jadasz cały dzień — porozmawiaj z lekarzem o **dawce** lub **godzinie** przyjmowania.

SKOKI MASY CIAŁA

Duże wahania związane z cyklami pomijania-objadania. **Dietetyk/-czka znający/-a ADHD** + ewentualnie psycholog/-żka. Nie kolejne dieta.

Klucz: Odżywianie w ADHD nie jest „dietą cud” — to **stabilizacja glukozy** i wsparcie dla mózgu, który już ma deficyt dopaminy. Sonuga-Barke i wsp. (2013): zmiany dietetyczne *nie zastępują* leków ani terapii — wspierają. Najsilniejsze efekty: śniadanie z białkiem, regularne posiłki, picie wody, eliminacja sztucznych barwników. *Zaczynij od jednego*. Dla większości pacjentów największą zmianę daje pierwsza: śniadanie z białkiem. Tylko to przez 2 tygodnie — i sprawdź, czy poranna uwaga się różni.